

PAUTA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS RECURRENTES PARA PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

ACV (ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR) TEC TUMOR CEREBRAL	HEMIPARESIA (INDICAR LATERALIDAD) 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	ALTERACIÓN DE LA MARCHA 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	PARESIA BRAQUIAL (INDICAR LATERALIDAD) 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	PARESIA CRURAL (INDICAR LATERALIDAD) 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	HEMIANOPSIA HOMÓNIMA (INDICAR LATERALIDAD) 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	CEGUERA/CEGUERA LEGAL/BAJA VISIÓN (INDICAR LATERALIDAD) 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	HIPOACUSIA (INDICAR TIPO, GRADO Y LATERALIDAD) 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	ATAXIA 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	AFASIA 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	TRASTORNO DE LA DEGLUCIÓN CON USO DE SNG/GTT 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
	DETERIORO COGNITIVO 2° A ACV / TEC / TUMOR CEREBRAL OPERADO
CÁNCER	CUANDO SE ENCUENTRA EN ETAPA IV O METASTÁSICO, SE DEBE CONSIGNAR COMO TAL Y, EN CASO DE PRESENTAR SECUELAS, INDICARLAS EN LOS DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS CUANDO SE TRATA DE PATOLOGÍAS EN ETAPAS PREVIAS, SE DEBE INDICAR LA SECUELA ACTUAL DE DICHA PATOLOGÍA CUANDO SE TRATA DE UNA CÁNCER OPERADO O EN REMISIÓN, SE DEBE INDICAR LA SECUELA DE LA PATOLOGÍA O DE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS. EJEMPLOS: - LIMITACIÓN FUNCIONAL DE ESD 2° A MASTECTOMÍA TOTAL EN CONTEXTO DE CANCER DE MAMA - CÁNCER CERVICOUTERINO EN ETAPA IV - CÁNCER PULMONAR CON METÁSTASIS ÓSEAS - POLINEUROPATÍA SENSITIVO MOTORA 2° A QUIMIOTERAPIA EN CONTEXTO DE CÁNCER RENAL EN REMISIÓN - CÁNCER DE COLON OPERADO CON USO DE COLOSTOMÍA - CÁNCER DE VEJIGA CON USO DE CUP (CATETER URINARIO PERMANENTE) - DOLOR CRÓNICO DE (SEGMENTO AFECTADO) 2° A RADIOTERAPIA POR CÁNCER DE (SEGMENTO AFECTADO) - AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL DERECHA 2° A OSTEOSARCOMA - HIPOACUSIA SEVERA OD OTOTÓXICA 2° A QUIMIOTERAPIA POR CANCER RENAL

AMPUTACIONES	AMPUTACIÓN (INDICAR SEGMENTO¹) (INDICAR LATERALIDAD) 2° A: - PIE DIABÉTICO COMPLICADO - ISQUEMIA CRÍTICA - HERIDA CORTANTE - HERIDA DE BALA - TRAUMA - GANGRENA - OSTEOSARCOMA - ETC. ¹DE PRIMER ORTEJO, TRANSMETATARSIANA, DE MEDIO PIE, TRANSMALEOLAR, TRANSTIBIAL, TRANSFEMORAL, TIPO DESARTICULACIÓN DE CADERA, IFD, IFP, DE DEDOS LARGOS, DE PULGAR, DE MUÑECA, DE ANTEBRAZO, DE CODO, TRANSHUMERAL, DESARTICULACIÓN DE HOMBRO.
PATOLOGÍAS DE COLUMNA	INDICAR SIEMPRE LA SECUELA Y LUEGO LA PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR Y SU SEGMENTO. EJEMPLOS: - DOLOR CRÓNICO 2° A DISCOPATÍAS DEGENERATIVAS DORSALES MULTISEGMENTARIAS - CERVICOBRAQUIALGIA BILATERAL 2° A DISCOPATÍAS Y ESPONDILOARTROSIS CERVICAL - SÍNDROME DE DOLOR LUMBAR CRÓNICO 2° A ARTROSIS Y DISCOPATÍAS L4-L5 Y L5-S1 - ALTERACIÓN DE LA MARCHA 2° A HNP L5-S1 CON RADICULOPATÍA - LIMITACIÓN DE MOVILIDAD 2° A HNP LUMBARES OPERADAS CON ARTRODESIS - DOLOR CRÓNICO 2° A FX DE L1 OPERADA - LIMITACIÓN DE MOVILIDAD DE COLUMNA CERVICAL 2° A SD DE ARNOLD CHIARI TIPO 1

LOS DIAGNÓSTICOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, DEBERÁN SER CONSIGNADOS TAL COMO SE INDICA:

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO	- ENFERMEDAD DE PARKINSON - DISTONÍA - ATAXIA CEREBELOSA - ATAXIA HEREDITARIA - ENFERMEDAD DE HUNTINGTON - TEMBLOR ESENCIAL - PARKINSONISMO
----------------------------------	---

PATOLOGÍAS AUTOINMUNES	- ARTRITIS REUMATOIDEA - ARTRITIS PSORIÁSICA - ESCLERODERMIA - ESPONDILITIS ANQUILOSANTE - LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO - MIASTENIA GRAVIS - POLIMIOSITIS / DERMATOMIOSITIS - SÍNDROME DE SJÖGREN - COLITIS ULCEROSA
ENFERMEDAD RENAL	INDICAR ETAPA Y REQUERIMIENTO DE HEMO O PERITONEO DIÁLISIS. EJ: - ERC ETAPA V EN HD
TRASPLANTES	INMUNOSUPRESIÓN CRÓNICA EN CONTEXTO DE TRASPLANTE (INDICAR ÓRGANO)

EPILEPSIA	CONSIGNAR TAL COMO SE REPORTA EN ANTECEDENTES: - EPILEPSIA - EPILEPSIA FOCAL - EPILEPSIA REFRACTARIA - EPILEPSIA ESTRUCTURAL - EPILEPSIA GENERALIZADA
DEPENDENCIA FUNCIONAL	SEGÚN PUNTAJE DE BARTHEL O DEBE CONTAR CON REPORTE “LITERAL” DENTRO DE ANTECEDENTES CLÍNICOS: - DEPENDENCIA FUNCIONAL SEVERA - DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA
SÍNDROME DE DOWN	MENORES DE 7 AÑOS: - SÍNDROME DE DOWN - RDSM ASOCIADO A SD DE DOWN
	MAYORES DE 7 AÑOS (CON PSICOMETRÍA): DISCAPACIDAD INTELECTUAL (INDICAR GRADO) 2° A SD DE DOWN
CARDÍACOS	- INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA CF (INDICAR GRADO: I, II, III O IV) - CARDIOPATÍA CORONARIA - INSUFICIENCIA CARDÍACA 2° A IAM

PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES	CONSIGNAR SEGMENTO, LATERALIDAD, GRADO. EN CASO DE REPORTAR SECUELAS, DEBEN IR AL COMIENZO DEL DIAGNÓSTICO. EJ: - GONARTROSIS (INDICAR LATERALIDAD) (INDICAR GRADO SI ES QUE SE REPORTA) - COXARTROSIS (INDICAR LATERALIDAD) (INDICAR GRADO SI ES QUE SE REPORTA) - ALTERACIÓN DE LA MARCHA 2° A COXARTROSIS BILATERAL - DOLOR CRÓNICO DE PIE IZQUIERDO 2° A ARTROSIS POSTRAUMÁTICA - LIMITACIÓN FUNCIONAL DE EESS 2° A SD DE MANGUITO ROTADOR BILATERAL - LIMITACIÓN FUNCIONAL DE MANO IZQUIERDA 2° A SD DE TÚNEL CARPIANO
POLIOMIELITIS	SE DEBE CONSIGNAR LA <u>SECUELA</u> Y SEGMENTO AFECTADO. EJ: - ALTERACIÓN DE LA MARCHA 2° A POLIOMIELITIS - DISMETRÍA DE EEII 2° A POLIOMIELITIS - ACORTAMIENTO DE EID 2° A POLIOMIELITIS - ALTERACIÓN DE LA MARCHA 2° A ATROFIA MUSCULAR DE EII EN CONTEXTO DE POLIOMIELITIS - PARESIA DE EID 2° A POLIOMIELITIS - LIMITACIÓN FUNCIONAL DE ESD 2° A POLIOMIELITIS
SECUELAS TRAUMÁTICAS	INDICAR SECUELA Y LUEGO LOS SEGMENTOS AFECTADOS POR EL TRAUMATISMO. EJ: - TETRAPLEJÍA 2° A TRM CERVICAL ASIA A - PARAPARESIA 2° A TRM NIVEL L2-L3 OPERADO - VEJIGA E INTESTINO NEUROGÉNICOS 2° A TRM - LIMITACIÓN FUNCIONAL DE MANO IZQUIERDA 2° A FX DE MUÑECA OPERADA - ALTERACIÓN DE LA MARCHA 2° A FX DE TIBIA DERECHA

	- ARTROSIS POSTRAUMÁTICA DE TOBILLO IZQUIERDO 2° A FX OPERADA - IMPOTENCIA FUNCIONAL DE ESD 2° A FX DE HÚMERO CON LESIÓN COMPLETA DE PLEXO BRAQUIAL - LIMITACIÓN FUNCIONAL DE MANO DERECHA 2° A HERIDA CORTANTE CON LESIÓN DE NERVIIO CUBITAL - LIMITACIÓN DE MOVILIDAD DE ESD 2° A QUEMADURA
PARÁLISIS CEREBRAL	DEBE INDICAR TIPO (ESPÁSTICA, MIXTA, ATÁXICA, DISCINÉTICA), TOPOGRAFÍA (HEMI, PARA, TETRA, DI Y MONOPLÉJIA O PARESIA) Y LATERALIDAD SEGÚN CORRESPONDA. EJ: - PC TIPO HEMIPARESIA ESPÁSTICA DERECHA - PC TIPO DIPLEJÍA ESPÁSTICA IZQUIERDA - PC TIPO TETRAPARESIA MIXTA
PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS	INDICAR DIAGNÓSTICO Y REQUERIMIENTO DE SOPORTE VITAL O AATT, EN CASO DE REQUERIRLO: - EPOC OXÍGENODEPENDIENTE - SAHOS CON USO DE CPAP NOCTURNO - FIBROSIS PULMONAR - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA CON VMI POR TQT
VIH / SIDA	POR RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA, SE DEBE CONSIGNAR COMO: - B24 EN TARV (SI CORRESPONDE)
USUARIOS CON USO DE EQUIPOS DE SOPORTE VITAL	SE DEBE INDICAR EL DIAGNÓSTICO ASOCIADO Y LUEGO "CON USO DE xxxx". EJ: - DISPLASIA BRONCOPULMONAR CON USO DE VMI POR TQT - TRASTORNO DE LA DEGLUCIÓN CON USO DE GTT/SNG - FIBROSIS PULMONAR CON USO DE OXÍGENO DOMICILIARIO/OXIGENODEPENDIENTE
PATOLOGIAS AUDITIVAS	SE DEBE INDICAR TIPO (NEUROSENSORIAL, CONDUCTIVA, MIXTA), LATERALIDAD (DERECHA/IZQUIERDA, BILATERAL) Y GRADO DE SEVERIDAD (LEVE, MODERADO, SEVERO, PROFUNDO) EJ: - HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL SEVERA - HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL SEVERA - HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL: SEVERA OD, MODERADA OI. - ANACUSIA OI, HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SEVERA OD - HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL SEVERA CON IC (implante coclear)

PATOLOGIAS VISUALES	SE DEBE INDICAR CLASIFICACION DE AGUDEZA VISUAL CON CORRECCION (VISION SUBNORMAL, BAJA VISION, CEGUERA LEGAL, CEGUERA) 2° A PATOLOGÍA VISUAL - CEGUERA LEGAL BILATERAL 2° A ALTA MIOPIA - CEGUERA LEGAL OD, BAJA VISIÓN OI 2° A RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA - BAJA VISIÓN BILATERAL 2° A DESPRENDIMIENTO DE RETINA - CEGUERA OI 2° A TRAUMA OCULAR CEGUERA LEGAL (Si el oftalmólogo indica ceguera legal con patología asociada: evaluar y considerar diagnóstico, no pedir agudeza visual). *CUANDO NO HAY AGUDEZA VISUAL (AV): - Vicio de refracción (VR) sin patología asociada: Se rechaza, no constituye discapacidad, si quiere apelar debe adjuntar agudeza visual - VR con patología asociada: Evaluar funcionalidad y determinar porcentaje. - Casos antiguos asociados a VR (ingresados el 2024): Aplicar tabla de agudeza visual para valoración, evaluar y pasar a comisión, no pedir agudeza visual. Comisión podría pedir adjuntar agudeza visual, dependiendo del caso. Nota: La discapacidad visual (vicios de refracción) se debe evaluar con la mejor corrección óptica posible, esto teniendo siempre en cuenta el contexto biopsicosocial.
DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	SE DEBE INDICAR GRADO DE SEVERIDAD (LEVE, MODERADO, SEVERO, PROFUNDO) O FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LIMITROFE. DISCAPACIDAD INTELLECTUAL NO ESPECIFICADO (En caso de que no adjuntar psicometría o reportar el grado. SI LA DISCAPACIDAD INTELLECTUAL ESTÁ ASOCIADA A SÍNDROME GENÉTICO, SE INDICA: DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (GRADO DE SEVERIDAD) ASOCIADO A (SINDROME GENETICO) EJ: -DISCAPACIDAD INTELLECTUAL MODERADA ASOCIADA A SÍNDROME DE DOWN. *COEFICIENTE INTELLECTUAL LIMÍTROFE: NO ES UNA CONDICIÓN DE SALUD QUE GENERE DISCAPACIDAD

DEMENCIAS	SE DEBE INDICAR TIPO DE DEMENCIAS SEGÚN REPORTE CLINICO: - DEMENCIA - DEMENCIA TIPO ALZHEIMER - DEMENCIA VASCULAR - DEMENCIA MIXTA - TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR - DETERIORO COGNITIVO - ETC.
TRASTORNOS PSIQUIATRICOS	CONSIGNAR SEGÚN NOMENCLATURA DSM V - TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO POR ABUSO DE SUSTANCIAS - TRASTORNO BIPOLAR - TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO - TRASTORNO PSICÓTICO - ESQUIZOFRENIA HEBEFRÉNICA - EZQUIZOFRENIA CATATÓNICO-PARANOIDE

PATOLOGÍAS METABÓLICAS:

- ✓ PATOLOGÍAS METABÓLICAS NO CONSTITUYEN UNA CAUSA DE DISCAPACIDAD POR SÍ SOLAS, A MENOS QUE GENEREN SECUELAS EN LA FUNCIONALIDAD: AMPUTACIONES 2° A DM, ACV POR CAUSA EMBÓLICA O POR HTA, NEUROPATÍAS 2° A DM, RETINOPATÍA DIABÉTICA/HIPERTENSIVA O GLAUCOMA, ETC.
- ✓ EN CASO DE PRESENTAR ÚNICAMENTE PATOLOGÍAS COMO HTA, DIABETES MELLITUS, DISLIPIDEMIA, HIPOTIROIDISMO, ASMA, ETC, SIN INDICAR SECUELAS O COMPROMISO FUNCIONAL SECUNDARIO, SE DEBE SUGERIR RECHAZO DEL TRÁMITE.
- ✓ EN CASOS DE DEMENCIA QUE ADEMÁS PRESENTEN HTA, Y/O DM Y/O HIPOTIRODISMO, ES POSIBLE AGREGAR ORIGEN FISICO 2º Y DEJAR REGISTRADO COMO DIAGNOSTICO/S SECUNDARIOS. (CRITERIO CLÍNICO AGREGADO POR EQUIPO MÉDICOS CONTRALORES)